

BRAZ GONÇALVES DA SILVA				
SINTOMAS / QUEIXAS	Ronca / Aritmia /			
MEDICAMENTOS	SeloZok / furosemida / malato enalapril espironolactona			
HORA QUE DORME :	23	HORA QUE ACORDA: 8h		
BANHEIRO	1x			
TIPO DE RESPIRAÇÃO	Sim			
PRATICA EXERCICIO	caminhadora / Bike			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ :	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:	
IDADE: 64	PESO: 78	IAH: 49,3	MALLAMPATI: 2	SPO2: 91% SpO2 min 56%
Alt: 165				
01/03/23 - P=				
adaptação de CPAP aut.				
03/03/23 P= 4,0 à 14 cmH ₂ O P. teropia = 8 cmH ₂ O APE = 2 Auto umidif. 4				
09/03/23 P= 11,6 cmH ₂ O IAH = 2,7 e/ev M. de uso: 9h50' Fuga: 0,0 l/min manuseu o septo nasal pronto proteção				
16/03/23 P= 8,1 cmH ₂ O M. de uso: 09hr IAH = 2 e/ev Fuga = 0 l/min Relata melhora da concentração e ação fua.				
23/03/23 P= 7,9 cmH ₂ O fixei em 8,5 devido ronco IAH = 1,6 e/ev M. de uso: 8hr Fuga = 9 l/min fua.				
13/04/23 P= 9 cmH ₂ O IAH = 1,5 e/ev M. de uso: 9hr Relata melhora da melhora e no exerc. físico fua.				
20/06/23 P= 9,0 cmH ₂ O IAH = 1,9 e/ev M. de uso: 7hr Rel. faz atraso de fase. fua				
19/09/23 P= 9,0 cmH ₂ O IAH = 1,8 e/ev M. de uso: fua				
30/04/24 P= 9,0 IAH = 1,4 e/ev M. de uso: 7h30' Fuga = 12,2 e/ev. Desvio septo. fua				
04/07/24 P= 9,0 IAH = 1,2 e/ev M. de uso: 6h30' fua				

12/09
24
 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
Bem adaptado, sem queixas.
Jua

12/12
24
 $P = 9.0$
 $IAH = 1.3$
m. de uso: 6h43'
Bem adaptado
fuga: 16 lpm.
Jua

19/02
25
 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1.3 \text{ e/h}$
m. de uso: 5h40'
fuga: 12.4 l/m
Bem adaptada
Natacha

14/05
25
 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1.6 \text{ e/h}$
m. de uso: 5h49'
fuga: 9.9 l/m
usu 15/30 dias
Orienta rotina de uso e horário de sono.
Natacha

2

Encaminhar a

--

Nome: BRAZ
 Nome: GONÇALVES DA SILVA
 Rua: _____
 Código postal, Cidade: _____
 Telefone: _____

ID paciente:	
Data de nasc.:	12/02/1959
Altura:	165 cm
Peso:	90 kg
BMI:	33.4 kg/m ²

Data:	19/02/2022
Iniciar:	21:19
Terminar:	06:57
Duração:	9 h 38 min.

Iniciar: 21:29 .
Terminar: 06:55 .
Duração: 9 h 23 min.

* Consultar o manual clínico para obter informações sobre as abreviaturas e os parâmetros padrão do ResMed

Índices		Normal		Resultado	
IAH*:	49,3	< 5 / h	Média de respirações por minuto [rpm]:	13,72	
IR*:	49,9	< 5	Respirações:	7729	
Índice de apnéia:	7,3	< 5 / h	Apnéias:	69	
IAI:	0		Apnéias indeterminadas:	0 (0%)	
IAO:	7,3		Apnéias obstrutivas:	69 (100%)	
IAC:	0		Apnéias centrais:	0 (0%)	
IAM:	0		Apnéias mistas:	0 (0%)	
Índice de hipopneia:	42	< 5 / h	Hipopneias:	394	
% de limite de fluxo Rp sem Rs (Lf):	7	< Aprox. 60	Limitação de fluxo, Rp sem Rs (Lf):	551	
% de limite de fluxo Rp com Rs (LR):	1	< Aprox. 40	Limitação de fluxo, Rp com Rs (LR):	50	
			Eventos de ressonância:		1218
Índice de Dessaturação de Oxigênio*:	50,2	< 5 / h	Número de dessaturações:	471	
Saturação média:	91	94% - 98%	Saturação <= 90% :	131 min. (23%)	
Menor dessaturação:	56	-	Saturação <= 85% :	16 min. (3%)	
Saturação mínima:	56	90% - 98%	Saturação <= 80% :	7 min. (1%)	
Saturação basal:	94	%			
Frequência de pulso mínima:	53	> 40 bpm			
Frequência de pulso máxima:	120	< 90 bpm			
Frequência de pulso média:	82	bpm			

Estado da análise: Editado manualmente

Parâmetros de análise usados (Definido pelo utilizador)

Apnéia [20%; 10s; 80s; 1,0s; 20%; 60%; 8%]; Hipopnéia [70%; 10s; 100s; 1,0s]; Ronco [6,0%; 0,3s; 3,5s; 0,5s]; Dessaturação [3,0%];

Comentários

Polissonografia tipo III realizada com o equipamento ApneaLink Air®. Os seguintes parâmetros foram obtidos: fluxo aéreo (cânula de pressão nasal), cinta tóraco-abdominal, saturação do oxigênio, frequência cardíaca e ronco.

Conclusão: Apneia obstrutiva do sono de intensidade grave

Índice de apneia-hipopneia = 49,3 eventos/hora.

(até 4,9 e/h = normal. 5-14,9 e/h = leve. 15-29,9 = moderada. > 30 e/h = grave)

Dr Rodrigo Pedrosa
CRM-PE 18282

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **BRAZ GONCALVES DA SILVA** (59 anos)
Convênio: **Prefeitura/nac**

VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA

Exame realizado via fossa nasal direita e esquerda com desvio de septo nasal grau 2 para esquerda area 2 e . Cornetos palidos e hipertrofos ++/4+ . Meatos livres. Estreitamento de VAS ao nivel de palato mole e de base de lingua . Sinais de laringite posterior .(RGE). Cicatriz em parede anterior da traqueia por traqueostomia sem causar obstrução

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Av. São João nº 570 Sala 23 Jd. Esplanada Fone: (12) 3922-5011
Cep 12242-840 São José dos Campos / SP